

Senioren in Deutschland: Charakteristika, Unterstützungsbedarf und digitale Lösungen

TL;DR

Deutschland altert rasant: 2024 waren rund 19,0 Millionen Menschen (23 % der Bevölkerung) 65 Jahre oder älter, ab 2035 wird jede vierte Person 67+ sein; über ein Drittel der Älteren lebt allein, rund 20 % sind armutsgefährdet und rund 6 Millionen Menschen sind pflegebedürftig.

Der Unterstützungsbedarf konzentriert sich auf Pflege, Mobilität, Sturz-/Notfallsicherheit, Einsamkeit sowie digitale Teilhabe: Zwar sind inzwischen drei Viertel der 65-Jährigen und Älteren online ("Silver Surfer"), aber nur rund die Hälfte der Bevölkerung verfügt über solide digitale Basiskompetenzen, und Millionen Ältere bleiben offline.

Es existiert ein breites, ausdifferenziertes Angebot digitaler Lösungen – von Hausnotruf/Sturzsensoren über AAL/Smart Home, Seniorenhandys und Senioren-Tablets bis zu Telemedizin und staatlich geförderten Teilhabe-Initiativen (DigitalPakt Alter, Digital-Kompass) – dessen Verbreitung aber an Kosten, Komplexität und fehlenden Kompetenzen scheitert.

Key Findings

Demografie: 19,0 Mio. Menschen ab 65 (2024, 23 % der Bevölkerung); 3,0 Mio. Hochbetagte ab 85. Ab 2035 wird jede vierte Person 67+ sein.

Lebenssituation: 34,0 % der 65+ leben allein, bei den 85+ sind es 56,0 %. Die meisten leben im eigenen Zuhause; nur eine Minderheit in Heimen.

Finanzen: Durchschnittliche Altersrente 2024 rund 1.154 € (Männer 1.405 €, Frauen 955 €); Armutsgefährdungsquote der 65+ bei 19,6 %.

Pflege: Rund 6,0 Mio. Pflegebedürftige (Ende 2024), knapp 85 % ambulant/zuhause versorgt.

Gesundheit: Rund 1,84 Mio. Demenzkranke (2023), 2,3 bis 2,7 Mio. bis 2050; hohe Sturz- und Frakturrisiken.

Digitalisierung: 74 % der 65+ online (2020: 48 %), aber starke Alters- und Bildungsunterschiede; nur rund 49 % der Gesamtbevölkerung mit digitaler Basiskompetenz.

Lösungen & Programme: Hausnotruf (Kassenleistung), AAL/Smart Home, Seniorenhandys (emporia, Doro), Senioren-Tablets, Telemedizin/DiGA; DigitalPakt Alter und Digital-Kompass als staatlich geförderte Teilhabe-Initiativen.

Details

1. Eigenschaften/Charakteristika von Senioren in Deutschland

Demografische Daten. Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist die Zahl der 65-Jährigen und Älteren seit 1991 von 12,0 Millionen auf 19,0 Millionen im Jahr 2024 gestiegen; ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wuchs von 15 % (1991) auf 23 % (2024). Besonders stark wächst die Gruppe der Hochbetagten: Die Zahl der Menschen ab 85 Jahren stieg von knapp 1,2 Millionen (1991) auf 3,0 Millionen (2024). Der Altenquotient (Personen ab 65 je 100 Personen im Alter von 20 bis unter 65) lag 2024 bei etwa 39. [Statistisches Bundesamt](#)

↗
[Statistisches Bundesamt](#)

↗

Für die Zukunft zeigt die 16. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung von Destatis, vorgestellt auf einer Pressekonferenz am 11. Dezember 2025: "Im Jahr 2035 wird jede vierte Person in Deutschland 67 Jahre oder älter sein ... Zum Vergleich: Im Jahr 2024 war nur jede fünfte Person im Rentenalter ab 67 Jahren." Die Zahl der Personen im Rentenalter (67+) steigt bis 2038 auf 20,5 bis 21,3 Millionen und damit um mindestens 3,8 Millionen gegenüber 2024, während die Zahl der Menschen im Erwerbsalter bis 2070 um mindestens 4,0 Millionen sinkt. Treiber ist der Übergang der Babyboomer-Generation in den Ruhestand. Ältere Vorausberechnungen (15. koordinierte, Basis 2022) sahen den Anteil der 65+ bis 2070 auf knapp 30 % steigen. [Statistisches Bundesamt + 2](#)

↗
Lebenssituation und Wohnform. Nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 leben in Deutschland gut 17,0 Millionen Menschen allein (20,6 % der Bevölkerung). Ältere Menschen sind besonders betroffen: In der Altersgruppe 65+ wohnt gut jede dritte Person allein (34,0 %), bei den mindestens 85-Jährigen mehr als jede zweite (56,0 %). Frauen sind wegen der höheren Lebenserwartung und der häufigeren Verwitwung deutlich öfter allein als Männer. Die große Mehrheit der Älteren lebt im eigenen Zuhause; die Heimunterbringung betrifft nur eine Minderheit, überwiegend Menschen mit höheren Pflegegraden.

[Statistisches Bundesamt](#)

↗
Einkommens-/Rentensituation. Die durchschnittliche Altersrente im Bestand lag 2024 bei rund 1.154 € Zahlbetrag (Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Statistikband Rente 2024). Dabei besteht ein erheblicher Geschlechterunterschied: Frauen erhielten mit durchschnittlich 955 € nur rund zwei Drittel dessen, was Männer durchschnittlich als Altersrente bezogen (1.405 €) – laut Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichem Institut (WSI) eine Rentenlücke von 32 Prozentpunkten bzw. 450 €. Die Armutsgefährdungsquote der Menschen ab 65 lag 2024 bei 19,6 % – also rund jeder Fünfte. Die Armutsgefährdungsschwelle für Alleinlebende lag 2025 bei etwa 1.446 € netto/Monat. Alleinlebende Ältere und insbesondere Frauen tragen ein erhöhtes Armutsrisiko. [Beneversichert + 3](#)

↗
Gesundheitszustand. Mit dem Alter steigen Multimorbidität und Pflegebedarf. Laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft (Infoblatt 1, September 2024) lebten 2023 rund 1,84 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, davon etwa 1,2 Millionen Frauen; 2023 gab es zwischen 364.000 und 445.000 Neuerkrankungen. Für die Zukunft prognostiziert die Gesellschaft: "wird sich die Zahl der Menschen mit Demenz über 65 Jahren bis zum Jahr 2050 auf 2,3 bis 2,7 Millionen erhöhen" (sofern kein Durchbruch in Prävention oder Therapie gelingt). Sturzrisiken sind zentral: Nach der RKI-Gesundheitsberichterstattung ("Gesundheit 65+", Erhebung 2022) waren 23,8 % der Personen ab 65 Jahren mindestens einmal in den letzten 12 Monaten gestürzt; Menschen ab 80 Jahren stürzten häufiger (33,5 %) als 65- bis 79-Jährige (19,2 %). Jährlich werden rund 120.000 Oberschenkelhalsbrüche versorgt; die Folgen sind schwerwiegend (30-Tage-Sterblichkeit über 10 %, 1-Jahres-Sterblichkeit ca. 25 %, hohes Risiko dauerhafter Pflegebedürftigkeit). [Deutsche Alzheimer Gesellschaft + 4](#)

↗
Digitale Kompetenz und Internetnutzung ("Silver Surfer"). Laut einer Bitkom-Studie (im Auftrag u. a. des BMBFSFJ, 2025, n=1.004) gilt: "Während vor fünf Jahren erst knapp die Hälfte (48 Prozent) ... online waren, nutzen inzwischen rund drei Viertel (74 Prozent) der Deutschen ab 65 Jahren das Internet." Männer sind mit 78 % etwas häufiger online als Frauen (70 %). Die Nutzung sinkt stark mit dem Alter: 65-69 Jahre 98 %, 70-74 Jahre 85 %, 75-79 Jahre 64 %, ab 80 Jahre nur 49 %. Genutzt wird das Netz vor allem für Kommunikation (92 % E-Mail, 88 % Textnachrichten, 60 % soziale Netzwerke, 50 % Videotelefonie) und Alltagsorganisation (80 % Online-Banking, 76 % Online-Shopping, 57 % Navigation, 47 % Gesundheits-/Fitness-Apps). Der D21-Digital-Index 2024/2025 zeigt jedoch: Nur rund 49 % der

Gesamtbevölkerung verfügen über digitale Basiskompetenzen; bei Älteren ist der Anteil geringer. Die SIM-Studie 2024 nennt 87 % Online-Anteil der ab 60-Jährigen (Anstieg von 6 Prozentpunkten seit 2021), bei den über 80-Jährigen 62 %. Die häufigsten Gründe der Nichtnutzung: kein Interesse (54 %), zu kompliziert (42 %), "Freunde oder Familie erledigen alles" (30 %). Zwei Drittel der ab 60-Jährigen berichten von eingeschränkter digitaler Gesundheitskompetenz. [Bitkom](#)

↗
[Langenhagener-News](#)

↗
Mediennutzung. Nach der ARD/ZDF-Medienstudie 2025 bleibt Video (v. a. lineares Fernsehen) das wichtigste Medium der ab 50-Jährigen. Bei den über 70-Jährigen liegt die tägliche Videonutzung bei rund 269 Minuten. Gleichzeitig wird die Mediennutzung der Älteren digitaler: Der Anteil zeitsouveräner (non-linearer) Videonutzung bei den 50- bis 59-Jährigen stieg von 15 % (2021) auf 42 % (2025). Die beiden ältesten Teilgruppen wenden bis zu 95 % ihrer Audionutzung für lineares Radio auf. Die Mediatheken von ARD und ZDF liegen bei den ab 50-Jährigen bei den meistgenutzten Videoangeboten vorn, gefolgt von Amazon Prime Video und Netflix. [Media-perspektiven + 4](#)

↗ 2. Unterstützungsbedarf von Senioren in Deutschland

Pflegebedürftigkeit und Pflegegrade. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist stark gestiegen: Ende 2023 waren es laut Destatis knapp 5,7 Millionen (2021: 5,0 Mio.). Nach der Pflegestatistik 2024 des GKV-Spitzenverbandes erreichte sie exakt 6.011.679 Personen (+432.350 bzw. +7,8 % gegenüber 2023). Davon wurden 5.103.130 ambulant/zuhause versorgt (84,9 %, +9,1 %) und 908.549 stationär (15,1 %). Der höchste Zuwachs zeigte sich in Pflegegrad 1 (+10,3 %), was den wachsenden präventiven und niederschweligen Bedarf unterstreicht. Der starke Anstieg über die reine demografische Entwicklung hinaus geht auch auf den seit 2017 weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriff zurück. Da die große Mehrheit zuhause versorgt wird – häufig durch Angehörige –, konzentriert sich der Unterstützungsbedarf auf das häusliche Umfeld. [Statistisches Bundesamt + 6](#)

↗
Mobilität. Eingeschränkte Mobilität ist laut Forschung (u. a. NRW80+-Studie) ein zentraler Prädiktor für soziale Isolation und Einsamkeit. Fehlende Barrierefreiheit (Cafés, ÖPNV, Wohnumfeld) schränkt die Wahl der Aktivitäten ein und erschwert teils sogar das Verlassen des Hauses; nachlassendes Seh- und Hörvermögen verstärkt das Problem.

Soziale Isolation und Einsamkeit. Etwa 10 % der Erwachsenen in Deutschland fühlen sich oft einsam. Das Risiko sozialer Isolation liegt laut Deutschem Alterssurvey (DEAS) bei etwa 12 % der 65-Jährigen und steigt bis zum 90. Lebensjahr auf etwa 22 %. Das erste Einsamkeitsbarometer für Deutschland (BMFSFJ / Kompetenznetz Einsamkeit, vorgestellt am 30. Mai 2024, Datenbasis SOEP) zeigt, dass Personen über 75 Jahren im Längsschnitt am stärksten von Einsamkeit betroffen sind – wobei der Einzeljahreswert 2021 für die Ab-75-Jährigen (10,2 %) unterhalb des Wertes der jüngsten Erwachsenengruppe lag (18–29 Jahre: 14,1 %); der Höchstwert der Gesamtbevölkerung wurde im Corona-Jahr 2020 mit 28,2 % erreicht. Auslöser im Alter sind Verwitwung, Wegzug Angehöriger, eingeschränkte Mobilität und nachlassende Sinne. Chronische Einsamkeit ist ein erheblicher Gesundheitsrisikofaktor (u. a. Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhte Mortalität).

Alltagsbewältigung, Gesundheitsversorgung, Behörden. Unterstützung wird beim Einkaufen, im Haushalt, bei Arztterminen und im Umgang mit Behörden/Bürokratie benötigt. Die zunehmende Digitalisierung von Verwaltung (E-Government), Banking und Gesundheitswesen (z. B. E-Rezept, seit 1. Januar 2024 für gesetzlich Versicherte verpflichtend) erzeugt zusätzlichen Unterstützungsbedarf, wenn digitale Kompetenzen fehlen.

Digitale Teilhabe. Barrieren sind Angst vor Datenmissbrauch und Betrug, Unsicherheit im Umgang mit der Technik, nicht intuitive Gestaltung von Apps und Webseiten sowie Kosten für Anschaffung und Wartung. Gewünscht werden vor allem kostenlose oder günstige Kurse vor Ort: Zwei Drittel (66 %) der Älteren wünschen sich solche Schulungen. Die digitale Spaltung verläuft dabei nicht nur zwischen den Generationen, sondern auch innerhalb der älteren Bevölkerung – abhängig von Bildung, Einkommen und Geschlecht. [Ad Hoc News](#)

➤
Sicherheit (Sturz, Notfälle). Aufgrund der hohen Sturz- und Frakturzahlen besteht großer Bedarf an Notfallabsicherung (Hausnotruf, Sturzsensoren) sowie an sturzpräventiver Wohnraumanpassung (Stolperfallen beseitigen, Beleuchtung, Haltegriffe).

3. Digitale Lösungen für Senioren

Notrufsysteme / Hausnotruf. Der Hausnotruf ist ein von den Pflegekassen anerkanntes Hilfsmittel (§ 40 Abs. 1 SGB XI): Bei Vorliegen eines Pflegegrads übernehmen die Kassen in der Regel die Kosten (Basistarif rund 25,50 €/Monat, ggf. einmalige Anschlussgebühr). Anbieter sind u. a. das Deutsche Rote Kreuz, Johanniter, Malteser, Vitakt und die Telekom. Es gibt stationäre Systeme (auf die Wohnung begrenzt) und mobile Systeme mit GPS-Ortung für unterwegs. [Pflege Panorama](#)

➤
Sturzsensoren. Am Körper getragene Sensoren (Beschleunigungsmesser/Gyroskope) erkennen Stürze automatisch und lösen auch ohne Knopfdruck Alarm aus – besonders wichtig bei Bewusstlosigkeit. Beispiele sind libify (mit integriertem Armband-Sensor und Videotelefonie), Vitakt sowie Notrufuhren mit GPS und Sturzerkennung (z. B. TCL Safety Watch, JAMES B6). Neuere Entwicklungen umfassen radar-/optikbasierte Raumsensoren (z. B. im Badezimmer).

Ambient Assisted Living (AAL) / Smart Home. AAL ("altersgerechte Assistenzsysteme") vernetzt Sensoren und Smart-Home-Komponenten zur Alltagsunterstützung – Sicherheit (Hausnotruf, Sturz- und Rauchmelder), Komfort, Wohnumfeldsteuerung (Licht, Temperatur, Beschattung) und Telemedizin. In Deutschland ist der Begriff eng mit der Fraunhofer-Gesellschaft verbunden (Allianz aus mehreren Fraunhofer-Instituten, federführend Fraunhofer IGD). Zentrale Barriere sind hohe Kosten, insbesondere bei nachträglicher Umrüstung; die KfW fördert altersgerechten und barrierefreien Umbau mit Krediten und Zuschüssen. Genossenschaftliche/gemeinschaftliche Wohnprojekte (z. B. "Zusammenleben 4.0" in Halle, "WoQuaZ" in Weiterstadt) senken die Kosten pro Person.

Seniorenhandys und Tablets. Führender Hersteller einfacher Handys ist emporia (Österreich), gefolgt von Doro, Gigaset und Nokia. Das Angebot reicht von reinen Tastenhandys (emporia Simplicity, Doro-Klapphandys) über vereinfachte Android-Smartphones mit angepasster Oberfläche (emporia SMART-Serie, Doro Aurora) bis zu integrierten Notruftasten ("No-Panic-Button"). Laut emporia belegen Studien, dass für ältere Menschen die einfache Bedienung die wichtigste Eigenschaft eines Geräts ist. Senioren-Tablets (z. B. Media4Care, Lylu) bieten vereinfachte Oberflächen mit großen Symbolen, klaren Farben, vorkonfigurierten Konten (WhatsApp, E-Mail) und integrierter Videotelefonie.

Telemedizin / E-Health / DiGA. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA, "App auf Rezept") werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft, von Ärzten verschrieben und von den Krankenkassen erstattet. Rechtsgrundlage ist das Digitale-Versorgung-Gesetz (in Kraft seit 19.12.2019). Telemedizin/Videosprechstunden gewannen mit der Pandemie stark an Bedeutung. Die Nutzung durch Ältere ist jedoch noch begrenzt, und das Angebot in Arztpraxen bleibt lückenhaft – laut Fachleuten "steht E-Health noch zu oft im Konjunktiv".

Kommunikationslösungen gegen Einsamkeit. Videotelefonie (WhatsApp, Zoom, Google Meet) sowie speziell entwickelte Senioren-Tablets (casenio, Media4Care, Lylu, KOMP) unterstützen soziale Teilhabe.

Sprachassistenten (Alexa, Google Assistant, Siri) ermöglichen freihändige Bedienung, Erinnerungen (Medikamente, Trinken, Termine), das Vorlesen von Nachrichten sowie Anrufe per Zuruf – hilfreich bei motorischen oder visuellen Einschränkungen. Videotelefonie kann Einsamkeit lindern, ersetzt persönliche Begegnung jedoch nicht vollständig; sie erfordert zudem stabiles WLAN.

Förderprogramme und Initiativen. Zentrale staatlich geförderte Angebote:

DigitalPakt Alter (BMFSFJ/BMBFSFJ + BAGSO, gestartet 2021; seit 2023 sind alle 16 Bundesländer beteiligt): Aufbau lokaler "Erfahrungsorte" zur digitalen Teilhabe. In der Förderphase 2023–2025 unterstützte das Ministerium ältere Menschen mit über 3,1 Mio. Euro; nach eigener Angabe wurden im Jahr 2021 mehr als 15.000 ältere Menschen erreicht (Kontext: knapp 7 Millionen Menschen der Generation 60+ nutzen das Internet bislang nicht). Die Zahl der Erfahrungsorte wuchs von 100 (2021) auf ein Ziel von 300 (Ende 2025) und lag 2026 bei über 360. Ab 2026 tritt der Pakt in eine neue Förderphase ein: Gemeinsam mit der Commerzbank-Stiftung werden bis 2029 jährlich 25 Erfahrungsorte mit je 2.000 € gefördert (insgesamt 200.000 €), Schwerpunkt ländlicher Raum; zudem werden ab 2026 Kommunen für nachhaltige Teilhabestrukturen gefördert und ausgezeichnet.

Digital-Kompass (BAGSO + Deutschland sicher im Netz, gefördert vom Bund): bundesweit über 250 (aktuell knapp 300) Standorte mit ehrenamtlichen "Internetlotsen", kostenlosen Sprechstunden, Workshops und Materialien zu Videotelefonie, sicherer App-Nutzung und Betrugsschutz.

Silbernetz/Silbertelefon (Silbernetz e. V., gegründet von Elke Schilling): anonyme, täglich erreichbare Telefonhotline gegen Einsamkeit für Menschen ab 60. Anfang Januar 2026 ging der einmillionste Anruf ein. Die vom Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) durchgeführte Evaluationsstudie ReWiSil (Prä-Post-Design mit 208 Erstanrufenden im Alter von 50 bis 93 Jahren) zeigt, dass Erstanrufende emotional und sozial einsamer sind als etwa 95 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung und dass bereits kurze Gespräche von rund 20 Minuten die Einsamkeit bedeutsam verringern können. [BMBFSFJ](#)

Der **Achte Altersbericht** der Bundesregierung "Ältere Menschen und Digitalisierung" (Bericht der Sachverständigenkommission Januar 2020, veröffentlicht 12. August 2020, Bundestagsdrucksache 19/21650) beschreibt den ambivalenten Charakter der Digitalisierung – neue Möglichkeiten für Teilhabe und Autonomie einerseits, Risiken und neue Ungleichheiten andererseits – und fordert, den Internetzugang für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig vom Alter zu gewährleisten. Die BAGSO forderte darauf aufbauend ausdrücklich – analog zum "DigitalPakt Schule" – einen "DigitalPakt Alter" mit niedrigschwelligen Angeboten in allen Kommunen. Ergänzend wurde 2023 die Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit (Kabinettsbeschluss 13. Dezember 2023, federführend BMFSFJ) verabschiedet, die zunächst 111 und laut Monitoring 2024 bereits 132 ressortübergreifende Einzelmaßnahmen bündelt.

Recommendations

Für Angehörige und Betroffene (kurzfristig):

Bei vorliegendem Pflegegrad einen Hausnotruf beantragen (Kassenleistung nach § 40 SGB XI); bei erhöhtem Sturzrisiko ein System mit automatischer Sturzerkennung wählen.

Beim Erstestieg in die digitale Welt vorkonfigurierte Senioren-Tablets/-Smartphones mit einfacher Videotelefonie nutzen und einen lokalen Digital-Kompass-Standort für kostenlose Schulung aufsuchen. KfW-Zuschüsse für barrierefreien/altersgerechten Umbau und einfache sturzpräventive Maßnahmen (Beleuchtung, Haltegriffe, Beseitigung von Stolperfallen) prüfen.

Bei drohender Vereinsamung niederschwellige Angebote (Silbernetz, Besuchsdienste, Gruppenangebote) nutzen.

Für Anbieter und Produktentwickler:

Einfachheit priorisieren (große Schrift, klare Symbole, einheitliche, konsistente Bedienung) – die einfache Bedienung ist das wichtigste Kaufkriterium der Zielgruppe.

Datenschutz und Sicherheit transparent adressieren, da Betrugs- und Datenmissbrauchsangst eine Hauptbarriere ist.

Persönlichen Support, gedruckte Anleitungen und Vor-Ort-Begleitung mitliefern und automatische Sturzerkennung statt reiner Knopfdruck-Systeme priorisieren.

Für Politik und Kommunen:

Niederschwellige, kostenlose Präsenz-Schulungen flächendeckend ausbauen – insbesondere im ländlichen Raum und für Hochaltrige (66 % der Älteren wünschen sich Kurse vor Ort).

E-Government- und E-Health-Angebote barrierearm gestalten und analoge Alternativen erhalten, solange rund die Hälfte der über 80-Jährigen offline ist.

Einsamkeitsprävention (professionell geleitete Gruppenangebote, ehrenamtliche Besuchsdienste, Telefonhotlines) im Rahmen der Strategie gegen Einsamkeit weiter fördern.

Benchmarks, die diese Empfehlungen ändern würden: Steigt der Anteil der 65+ mit digitalen Basiskompetenzen deutlich über 60 %, verschiebt sich der Fokus von der Grundbefähigung hin zu fortgeschrittenen Anwendungen (KI-Assistenz, E-Health). Sinkt die Zahl der Offliner ab 80 Jahren unter ein kritisches Niveau, kann verstärkt auf rein digitale Angebote gesetzt werden; solange sie bei rund der Hälfte liegt, bleiben analoge Parallelangebote unverzichtbar.

Caveats

Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Jahren und Erhebungen (Destatis, GKV-Spitzenverband, Deutsche Rentenversicherung, Bitkom, D21, SIM, ARD/ZDF, RKI); leichte Abweichungen entstehen durch verschiedene Definitionen (z. B. "65+" vs. "60+", Einbezug von Pflegegrad 1).

Beim Einsamkeitsbarometer ist zu beachten: Der Befund "über 75-Jährige am stärksten betroffen" gilt in der Längsschnittbetrachtung; der Einzeljahreswert 2021 lag unter dem der jüngsten Erwachsenengruppe.

Kommerzielle Quellen (Anbieter-Vergleichsseiten, Statista-Snippets) wurden nur für allgemeine Marktübersichten genutzt; einige Statista-Werte waren hinter einer Paywall unvollständig.

Prognosen (Bevölkerung, Demenz, Pflege) sind modellabhängige Vorausberechnungen, keine Vorhersagen.

Die Zahl der Erfahrungsorte des DigitalPakt Alter schwankt je nach Stichtag und Förderrunde (100 → Ziel 300 (Ende 2025) → über 360 (2026)) und sollte stets mit Datum eingeordnet werden. Ein explizites Gesamtbudget der Strategie gegen Einsamkeit wurde nicht beziffert, da sie bestehende Ressort-Maßnahmen bündelt.